



FICHA DE INGRESO PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Conforme a normativa chilena – Uso Clínico

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

- Nombre: Julián Alonso Narvaez Salazar
- RUN:
- Fecha de nacimiento:
- Edad: 7 años
- Sexo: masculino
- Escolaridad: 2° básico
- Establecimiento educacional: Colegio Comunidad... (colegio especial con enfoque en neurodivergencias)
- Nombre del cuidador/tutor legal: ambos padres
- Contacto:

2. MOTIVO DE CONSULTA

- Descripción del motivo de consulta: “se desregula de manera frecuente e intensa”
- Tiempo de evolución: padres refiere diagnóstico de TEA 2 realizado por neuróloga a los 3 años. Consultan debido a nivel de desregulaciones actualmente ha ido en aumento en frecuencia e intensidad, refieren son diarias, 3 veces al día aproximadamente en donde llora, pega patadas, grita, a veces se autoagrede (golpes, cabezazos). Por las mañanas acude a terapias en psicoeduka pero se desregula cuando le ve pantallas a otros niños, en la tardes va a colegio de 2 a 5, ultimas semanas lo van a buscar antes. Hay dias en que se observa mas incómodo que otros yendo a colegio por lo que padres no lo envían, otros dias se le ve cómodo y contento asistiendo a colegio.
- Con respecto a gatillantes de desregulaciones padres describen que “80% son por algo sensorial, en especial de tipo auditivos (ej ruido de celulares) y 20% por nada” o bien no logran identificar gatillar claro. No tolera audifonos puestos. Refieren que su evolución con los años ha sido de avances y retrocesos, y que tiende a ser flexible frente a cambio de rutinas o transiciones. Cuando se encuentra en su estado basal lo observan bien de ánimo, es afectivo con su familia. Padres niegan eventos adversos en infancia o algún evento traumático, niegan disfunción familiar o ambiente familiar estresante. También destaca importante incomodidad con ciertas ropas con cierres, etiquetas o costuras, logran dar con ropa con la cual se siente cómodo.
- Se indaga en algun incomodidad a nivel corporal, niegan que refiere dolor abdominal o algun otros sintomas gastrointestinal como diarrea, constipación o meteorismo

- El sueño es descrito como adecuado, se acuesta siempre a la misma hora, no usa pantallas, logra conciliar el sueño rápido, sin interrupciones, no ronca ni bruxa ni tiene episodios de apneas.
- Destaca gran selectividad alimentaria: actualmente con dg nutricional de riesgo de desnutrir o desnutrido?? Poco claro, importante selectividad alimentaria (no come carne, escasos lácteos, recibe galletas, papas fritas, en las noches acepta pediasure. Padres refieren que lleva 7 días sin comer, acuden a pediatra quien solicita exámenes y según resultado de estos evaluarán hospitalización para instalar sonda nasogástrica. Si recibe líquidos. Padres relatan que antes recibía carnes por medio de papillas hasta que tuvo a los 3 años una faringitis y posterior a esta deja de comer varios alimentos (sin otros síntomas neuropsiquiátricos posterior a esta faringitis, solo deja de recibir ciertos alimentos)
- Habría recibido de parte de neurología inicio de risperidona, luego aripiprazol, y olanzapina esta última hace 8 meses, todas deben ser suspendidas ya que padres refiere reacción paradójica (aumenta la irritabilidad y agresividad)
- Padres no refieren estudio de neurología con imágenes o EEG
- Padres refieren que se sienten impotentes ya que han consultado con varios especialistas, con varios fármacos, lo ven pasándolo mal, con gran compromiso de funcionamiento diario a nivel familiar, escolar, social. Padres relatan que lo notan siempre “hipervigilante”, incluso cuando duerme, tenso, pendiente de todos los estímulos ambientales. Solicitan apoyo farmacológico, se entrega alternativa de estabilizador del ánimo, se explican posibles reacciones adversas y necesidad de iniciarlo una vez pasada etapa de anorexia aguda, cuando se encuentre alimentándose bien. Por otra parte debido a procesamiento sensorial tan alterado se solicita descartar algún foco de inflamación a nivel intestinal que produzca malestar o dolor (enf celiaca u otro) y evaluación por neurología para evaluar si requiere mayor estudio orgánico. Se sugerirá también evaluar niveles de ferritina, b12, o bien derivación a nutriología infantil según lo que refiera su pediatra en control.

3. ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS PERSONALES

- Diagnósticos previos: TEA nivel 2 no verbal (escasa comunicación principalmente con padres), diagnóstico realizado por neuróloga a los 3 años, se realizó ADOS-2 a esa edad
- Hospitalizaciones previas: no
- Tratamientos farmacológicos: estuvo con risperidona, aripiprazol, olanzapina indicados por neurología, con todos estos se describe reacción paradójica (aumentó irritabilidad y agresividad)
- Psicoterapia previa: acude a psicoeducación con TO y fonoaudiólogo 2 a 3 veces por semana
- Conductas autolesivas: en algunas ocasiones se pega, antes cabezazos / ideación suicida: no refiere según padres.

4. ANTECEDENTES MÉDICOS GENERALES

- Patologías médicas relevantes: sano, actualmente con dg nutricional de riesgo de desnutrir o desnutrido?? Poco claro, importante selectividad alimentaria (no come carne, escasos lácteos, recibe galletas, papas fritas, en las noches acepta pediasure. Padres refieren que lleva 7 días sin comer, acuden a pediatra quien solicita exámenes y según resultado de estos evaluarán hospitalización para instalar sonda nasogástrica. Si recibe líquidos. Padres relatan que antes recibía carnes por medio de papillas hasta que tuvo a los 3 años una faringitis y posterior a esta deja de comer varios alimentos (sin otros síntomas neuropsiquiátricos posterior a esta faringitis, solo deja de recibir ciertos alimentos)
- Tratamientos actuales: sin fármacos actualmente, padres refiere que solo a veces recibe vitaminas (omega 3, polivitamínico)
- Alergias: no

5. ANTECEDENTES FAMILIARES

- Antecedentes psiquiátricos familiares: padres no refieren enfermedades de salud mental ni por línea materna ni paterna
- Contexto psicosocial relevante: vive con ambos padres y hermana de 11 años. Padres refieren ambiente en casa armónico-funcional, sin antecedente de eventos adversos en infancia, padre con sistema de trabajo 7x7.

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL

- Apariencia: constitución mesomorfa, acorde a edad cronológica, vestimenta e higiene adecuada. Durante atención con padres se tapa oídos, cierra ojos, se observa discomfort
- Actitud: tensión al momento de la entrevista
- Psicomotricidad: se observa aumentada
- Lenguaje: No se comunica con entrevistador
- Pensamiento: no evaluable
- Ánimo no evaluable, padres refiere que cuando se encuentra no desregulado lo observan bien de ánimo, no triste, es afectivo con padres.
- Contacto visual no evaluable
- Juicio de realidad: no evaluable, sin discurso sugerente de psicosis
- Insight: no

7. EVALUACIÓN DE RIESGO

- Riesgo suicida: no, se encuentra siempre junto a un adulto responsable.
- Factores de riesgo: importante trastorno del procesamiento sensorial, dificultad para comunicarse, selectividad alimentaria importante, probable déficit de nutrientes, diagnóstico nutricional desnutrido, anorexia actual, gran compromiso de funcionamiento diario.
- Factores protectores: padres responsivos, afectivos, con buen nivel intelectual, adhiere a to y fono, semi adherencia escolar, impresiona buen vínculo con padres.

8. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA (DSM-5 / CIE-11)

- Diagnóstico principal: TEA nivel 2 a 3
- Diagnósticos secundarios: no verbal, t. Procesamiento sensorial severo, desnutrido

9. PLAN TERAPÉUTICO

- derivación a gastroenterólogo/a infantil (descartar enfermedad celiaca u otro foco inflamatorio abdominal)
- derivación a neuroinmunologa Dra. Schatter (centro develop +56988681219): evaluar necesidad de mayor estudio.
- órdenes de TO y fonoaudiólogo
- ácido valproico 250 mg/5 ml(depakene): 1 ml cada 12 horas (iniciar una vez que se encuentre alimentandose e hidratandose de manera normal, corresponderian exámenes de control por el medicamento 2 semanas posterior a su inicio, se envía orden. Frente a lesiones de tipo alergia en piel o mucosas, suspender y dar aviso)
- envío orden exs laboratorio para inicio estudio enfermedad celiaca, ferritina (una vez que pase episodio de anorexia aguda y junto con los exámenes de control por inicio de ácido valproico)
- Eventual derivación a nutriología pediátrica según evolución o indicación de pediatra.
- control en 1 mes

10. SEGUIMIENTO

- Fecha próximo control: 1 mes
- Red de apoyo: padres
- Indicaciones a cuidadores: en plan terapéutico

11. DATOS DEL PROFESIONAL

Nombre: Caterina Schiappacasse Arteaga
Especialidad:psiquiatra infanto juvenil
Registro profesional:105595
Centro de atención: Psicoeduka Santiago
Fecha: 15 de mayo de 2026